

11 - 6-Cas clinique et initiation RX semiologie sono maker

(0:00 - 0:38)

...de faire très attention, d'accord, de bien lire les mensonges, c'est ce qu'on donne à l'exemple, d'accord. Premier cas clé, il s'agit d'une patiente âgée de 55 ans, fonctionnaire dans une banque, pensionne pour les douleurs des deux genoux, évoluant depuis un an. L'intensité est évaluée à 60, quand je peux vous dire 6 sur 10, vous comprenez qu'il est 6 modéré.

(0:39 - 1:25)

Il est gêné lors de la marche, la station de boue prolongée, ainsi que lors de la montée des escaliers. Il est soulagé par le recours et ne peut plus faire son sport favori depuis 3 mois. Qu'est-ce que vous sortez de cette mensée ? Douleurs mécaniques, chroniques, modérées, pragmatiques, localisations des genoux, polygo, très très bien, polygo arthragique, d'accord, bien, et avec un retentissement.

(1:27 - 1:40)

L'examen clinique trouve une marche avec une canne. La patiente a besoin d'une canne pour marcher. La palpation note un dépanchement du genou droit.

(1:41 - 2:01)

La flexion des genoux est douloureuse et limitée du côté droit à 90 degrés. L'examen somatique est sans particularité. Qu'est-ce que je vous ai ajouté ? La limitation de la flexion, ça veut dire qu'il y a une raideur au niveau du genou droit.

(2:03 - 2:29)

Un dépanchement au niveau du genou droit. Comment classer ces douleurs ? Il s'agit du mono arthrique du genou droit. Tout le monde est d'accord, non ? Pourquoi ? De deux genoux, la patiente a un dépanchement dans un seul genou.

(2:32 - 2:42)

Très très bien, je vous ai parlé d'épanchement. S'il y avait des cils inflammatoires, je vous aurais dit qu'il y a des cils inflammatoires. C'est très important.

(2:43 - 2:58)

L'arthrite cinuvite doit être constatée par un médecin. Ce n'est pas ce que me rapportent les patients. Je dois constater quoi ? Les cils inflammatoires en regard.

(2:58 - 3:03)

Les trois. Tues mes patients. Remonte la chaleur.

(3:04 - 3:15)

Et la bonheur. Si il n'y a pas ça, on ne peut pas parler ni d'arthrite ni de cinuvite qui sont synonymes. Il s'agit d'une douleur chronique des genoux.

(3:16 - 3:26)

Oui, bravo. Pour l'arthropathie, au niveau cils, vous êtes mis. Au niveau arthropathie, vous aurez couché.

(3:26 - 3:41)

On est bien d'accord ? Une douleur aiguë ? Très très bien. A l'examen, il faut rechercher un épauchement articulaire. Oui.

(3:41 - 3:49)

Rechercher des points douloureux. Rechercher une douleur à la mobilisation des hanches. Très bien.

(3:50 - 4:00)

Les trois. Les diagnostics possibles sont une arthrose des genoux. Oui.

(4:01 - 4:07)

Une arthrite rhumatismale ? Non. Une arthrite septique ? Non. Je connais bien lui.

(4:08 - 4:19)

Non. Trois jours. Une arthrite goutteuse ? Non.

(4:19 - 4:28)

On est donc d'une douleur mécanique. Je ne veux pas que vous gâchiez de l'éthiologie inflammatoire. Bien.

(4:29 - 4:36)

Bien. Deuxième catholique. C'est une patiente âgée de 35 ans et de jeunes.

(4:37 - 4:46)

Institutrice. Présente depuis un mois des douleurs des deux poignets, les deux gouttes et les deux chevilles. Souffre la nuit.

(4:46 - 5:00)

Se réveille souvent pour prendre des antalgiques. Très gênée le matin à cause du dérouillage d'une raideur matinale de 40 minutes. Douleur inflammatoire ? Aiguë.

(5:00 - 5:04)

Aiguë. Polyarthragie. Bravo.

(5:05 - 5:15)

Chez une patiente âgée de 35 ans et de jeunes. À l'examen, je n'ai pas noté de signe inflammatoire. Il n'y a pas d'arthrite.

(5:16 - 5:28)

Il y a une douleur à la mobilisation de toutes les articulations actives. D'accord ? Diminution de la flexion du poignet gauche. Le reste de l'examen est tout à fait normal.

(5:29 - 5:39)

D'accord ? Il n'y a pas d'arthrite. Il a mal au niveau des poignets, des gouttes et des genoux. Avec une raideur du poignet gauche.

(5:40 - 5:50)

Quel est votre diagnostic ? Est-ce qu'il s'agit de polyarthrite ? Non. Oligoarthrite ? Non. De polyarthragie inflammatoire ? Oui.

(5:50 - 6:03)

Est-ce qu'il s'agit du polyarthropathie ? Pourquoi vous hésitez les autres ? Monsieur, vous êtes là. Écoutez. Polyarthropathie ? Oui.

(6:03 - 6:21)

Vous cochez ? Oui. Très bien. En faveur du caractère inflammatoire, on retient les éléments suivants.

(6:22 - 6:31)

La durée de la raideur matinale ? Oui. Les raides nocturnes ? Oui. Le siège de l'arthritisme articulaire ? Non.

(6:32 - 6:41)

Très bien. Le sexe féminin ? Non. Et d'autres choses.

(6:41 - 6:50)

La durée de l'hormonothérapie ? Oui. Très bien. Comment allez-vous ? Très bien.

(7:02 - 7:14)

Vous avez faim ? Vous êtes fatigué ? Oui. Mais le début d'année, vous n'avez rien encore vu. Allez-y.

(7:16 - 7:24)

15 minutes. 15 minutes et vous surrez. Il s'agit d'un homme âgé de 75 ans.

(7:25 - 7:42)

Il est suivi depuis 4 ans pour un cancer de la thyroïde. Il présente depuis 3 mois des douleurs osseuses diffuses au niveau du bassin et du fémur. Il a perdu 10 kg en 3 mois.

(7:43 - 7:56)

A l'examen, nous avons noté la thyroïde augmentée de taille. Une douleur à la pression des os. D'accord ? Les hanches, par contre, les articulations sont libres.

(7:57 - 8:04)

Non douloureuses à la mobilisation. Qu'est-ce qu'on a ? Douleurs osseuses diffuses. Très bien.

(8:07 - 8:24)

Améliorations de l'état général chez un patient âgé qui est suivi pour un cancer de la thyroïde. Révélerencé. Vous vous orientez vers quoi ? Attention, il peut s'agir de ? De métastase.

(8:24 - 8:40)

Très bien. Quel diagnostic a évolué ? Est-ce qu'il s'agit d'une arthropathie inflammatoire ? On l'a dit, les articulations sont libres. Il s'agit de douleurs osseuses.

(8:41 - 8:48)

Il s'agit d'une ostéopathie ? Oui. Alors, pathie des os. Il s'agit du coccyx bilatéral.

(8:50 - 9:04)

Très bien. Alors, le quatrième cas est celui d'un plombier qui est âgé de 44 ans. Consulte pour une douleur de l'épaule droite.

(9:04 - 9:21)

Évolue depuis trois semaines. La douleur est mécanique. La mobilisation passive et active de l'articulation entre l'abduction à 60, en dévulsion 80, une rotation externe à 20.

(9:22 - 9:44)

Les autres amplitudes sont normales. Rotation externe 20, en dévulsion 80. Comment il est ? Il a une raideur ? Qu'est-ce qu'il a, le patient ? C'est une douleur mécanique ? Aiguë ? Chronique ? Trois semaines.

(9:47 - 10:05)

Vous vous emmenez vers ? L'arthrose ? 44 ans. J'ai 44 ans. Maintenant, vous pensez que c'est loin ? Bien.

(10:06 - 10:31)

Vous vous emmenez vers quoi ? Optimopatie et immobilisation. Merci, les deux. Je suis déçu.

(10:42 - 10:55)

Rotation externe 20. Et vous vous emmenez vers quoi ? Articulaire. Vous vous pressurez.

(10:56 - 11:04)

C'est l'articulation. Examen. Bonjour, psychologue.

(11:04 - 11:15)

Conquis spécialité ? Bien. Qui les montre le diagnostic ? Est-ce qu'il s'agit d'une tendue de l'épaule ? Non. L'immobilité, les deux sont limitées.

(11:15 - 11:28)

Tu es d'accord ? Oui. Quand est-ce qu'on a une tendue empathique, attendez ? L'immobilité active ? Anormal. Passive ? Normal.

(11:29 - 11:35)

Rassurez-moi. Une raideur articulaire ? Oui. Oui, c'est une raideur.

(11:35 - 12:00)

De toute façon, 20 degrés. Quand est-ce qu'on est active ? Pourquoi ? Je ne vous ai pas dit. Je n'ai qu'un truc à vous dire.

(12:01 - 12:18)

Tu peux avoir un traumatisme et repasser. Hein ? Mais il est très rapide. 20 degrés, c'est rien.

(12:20 - 12:44)

60 degrés, c'est quoi ? 60 degrés, c'est quoi ? Quand je suis très active, qui m'a dit tout à l'heure ? C'est un inflammatory ? La douleur est mécanique. Est-ce que la capture rétractée a un problème ? Tu as vu ? Non, c'est une rétraction. Rétraction de la capsule.

(12:45 - 13:04)

D'accord ? Rupture tendineuse ? Rupture tendineuse ? Qu'est-ce qu'on a ? Le tableau ? Cereau paralytique ? Vous n'avez pas réalisé. Si, si, si. Vous n'avez pas réalisé.

(13:04 - 13:19)

Cereau paralytique, rupture tendineuse jusqu'à preuve du contraire. Épaule normale ? Vous m'auriez su. Non, non, ce n'est pas un inflammatory.

(13:21 - 13:33)

Il est mécanique. Il est mécanique, c'est une capsule qui est raide. D'accord ? Avec E2.

(13:35 - 14:03)

Pour une patiente âgée de 70 ans, on se trouve une boiterie avec une douleur mécanique de la hanche droite. Boiterie, douleur mécanique de la hanche. L'examen trouve un rachissement d'air souplement douloureux, sacroiliac normal, une limitation de la mobilité passive et active de la hanche droite.

(14:04 - 14:17)

L'élément C, je le fais toujours comme ça. L'examen, je prends mon temps à faire sortir les informations qui vont être utiles. Je mets l'âge.

(14:18 - 14:29)

Je fais attention à l'âge. 70 ans, j'ai ma petite idée. Boiterie ? Oui ? 65.

(14:29 - 14:47)

Je ne vais pas vous donner des 50 ans. Soit extrêmement âgés, 70 ans, soit des jeunes, à 40 ans. Puisque vous considérez 44 ans âgés, je vais vous donner 23 ans.

(14:49 - 15:05)

Ça va loin. Qu'est-ce qui est important à faire sortir ? Mobilité active et passive. Dignité.

(15:06 - 15:18)

C est mécanique. Ce tableau évoque une lésion de l'articulation corso-fémorale. Tendinopathie.

(15:19 - 15:29)

Coccite. J'espère que c'est bon. Je l'espère.

(15:29 - 15:44)

Pourquoi la douleur ? Une douleur viscérale projetée ? Non. Une lésion osseuse de voisinage ? Non. Très bien.

(15:45 - 15:55)

Une lampe scientifique. L5 commune. Se manifeste par... Une raideur achitienne.

(16:02 - 16:28)

Raideur achitienne. Oui, pourquoi ? Parce que... Vous devez faire attention. Est-ce que je vais vous dire lombo-sciatique ou sciatique ? Si vous vous rappelez lombo-sciatique, il va y avoir un syndrome achitien.

(16:28 - 16:39)

D'accord ? Syndrome achitien. Soit l'attitude, soit la raideur. D'accord ? Lombo, il va y avoir la participation achitienne.

(16:40 - 16:54)

Une douleur radiculaire ? Non. Vous hésitez ? C'est ? C'est commune. Commune veut dire ? Mécanique.

(16:55 - 17:05)

Une douleur nerveuse qui se termine sur le cinquième orteil. Sur le ? Le gros orteil. D'accord ? On répète.

(17:06 - 17:24)

La lombo-sciatique L5, qui est le territoire de la lombo-sciatique L5. Vous écrivez pour les gens qui n'ont pas pu suivre la dernière fois. Vous savez au niveau ? La fesse.

(17:26 - 17:36)

Postero, externe, au niveau de la cuisse. Elle devient entero, externe, au niveau de la jambe. Elle se termine sur ? Le gros orteil.

(17:37 - 17:44)

C'est bon ? Très bien. Entero, externe, au niveau de la jambe. Et se termine sur le gros orteil.

(17:44 - 17:50)

C'est bon ? Très bien. S1. Il est ? Postérieur.

(17:50 - 18:02)

Postérieur, au niveau de la fesse, de la cuisse. Elle devient ? Postero, externe, au niveau de la jambe. Pour se terminer sur ? Le mort externe du pied.

(18:02 - 18:18)

C'est compris ? Les lombo-sciatiques. Les rachygies sont de deux grands météorologiques. Il y a le lot de rachygies communes et symptomatiques ou secondaires.

(18:18 - 18:34)

Symptomatique veut dire secondaire. Mécanique, c'est tout ce qui est en rapport avec l'arthrose, la douleur des mécaniques. Cela intéresse un seul segment du rachis.

(18:34 - 18:45)

Une seule racine est touchée. Cela peut s'agir de l'arthrose, l'hernie distale ou un crêpe à blanc vert étroit. Tout ce qui est mécanique.

(18:45 - 19:06)

A l'opposé, symptomatique secondaire, la douleur inflammatoire. On peut trouver, oui, c'est une atteinte qui peut être globale. Plusieurs racines à la fois s'accompagnent de fièvres quand il s'agit d'une infection.

(19:06 - 19:16)

Elles peuvent s'accompagner d'altérations de l'état général. Et bien sûr, toutes les écologies inflammatoires. C'est bon ? J'espère.

(19:20 - 19:37)

Un liquide articulaire inflammatoire est défini par un taux de globules blancs supérieur à 2000. Oui, un taux de globules blancs inférieur à 1000, c'est mécanique. La présence de sang dans

l'articulation.

(19:37 - 19:43)

On n'a pas parlé de sang. On est bien d'accord. Ça m'intéresse peu.

(19:43 - 19:55)

La présence d'un taux de protides supérieur à 40. Là aussi, les protides ne vous intéressent pas.
La présence d'un germe dans l'articulation.

(19:56 - 20:27)

Pourquoi ? Supérieur à 2000. Pour vous, un liquide inflammatoire est obligatoire en septique ?
Non. Un liquide inflammatoire en globules septiques rematise mal et et met la mouline.

(20:27 - 20:58)

D'accord ? Ça veut dire inflammatoire parce que sinon, s'il n'y a pas de germe, je ne vais pas parler de liquide inflammatoire. Est-ce que c'est vrai ? Non. Inflammatoire, c'est quand vous avez des globules blancs supérieurs à 2000, quand vous avez l'aspect et les polynucléaires supérieurs à 58, mais ça n'a pas de rapport avec la présence ni de l'adapte, ni de l'adapte.

(20:59 - 21:13)

C'est-à-dire que l'inflammatoire, je vais préciser, goûteux, est en rapport avec la présence de gestos. Quand je vais dire infectieux ou aseptique, la présence de germes. On est bien d'accord ? Très très bien.

(21:14 - 21:25)

J'aimerais qu'elle agime bien les gens qui assistent au cours. C'est pourquoi, je donne toujours un secours, c'est-à-dire les informations que j'ai données au cours. Ce n'est pas mon cours que vous avez là.

(21:26 - 21:43)

D'accord ? On est bien d'accord ? Très bien. Dernier catalyse, je pense, lors d'une épaule douloureuse. Il s'agit d'une pathologie articulaire.

(21:43 - 21:53)

Articulaire. Sais-tu ? La fréquence est abarticulaire. Fais attention.

(21:54 - 22:01)

Il y avait beaucoup de fautes. Et c'est bête. Parce qu'ils ont pris abarticulaire.

(22:02 - 22:17)

Articulaire. D'accord ? Le capsulite rétractive est suspecté si les mobilisations actives et passives sont limitées. Une tendinopathie est suspectée si les mobilisations actives et passives sont limitées.

(22:18 - 22:30)

Une épaule pseudo-paralytique témoigne d'une rupture de la coiffe. Une épaule hyperalgique témoigne d'une arthrite septique. Hyperalgique.

(22:33 - 22:38)

Traumatique. Traumatique, quoi de neuf ? Tu y es. Tu es là.

(22:38 - 22:45)

Tu as une arthrite septique. Tu as une arthrite rhumatismale. Je vous demande de bien lire.

(22:45 - 22:51)

Je ne vais pas vous donner chez Kala quelque chose qui n'est pas sûr. On n'a pas vœu. On n'a pas vœu.

(22:51 - 23:03)

J'insiste. Je ne suis pas responsable de ce que vous êtes. Bien ? Il y a encore.

(23:05 - 23:30)

Un ancien sportif se présente pour une douleur mécanique du genou gauche, avec l'invention de blocage en flexion et une extension très douloureuse. Cette symptomatologie traduit un corps étranger, ça c'est un cadeau, c'est parmi les cadeaux que je peux vous donner. Ça signifie un corps étranger, intra-articulé.

(23:34 - 24:13)

Une douleur mécanique de la hanche peut s'accompagner de réveillotations provoquées par la douleur, être ressentie dans la région fessière avec irradiation postérieure, s'accompagner d'une poitrine orientée vers une agrocystrophie, être d'origine infectieuse.